



洪湖市人民医院
THE PEOPLE'S HOSPITAL OF HONGHU

2026



病例分析（一）

2026.07.25

临床病史

73岁，女性

主诉：发现肺占位1月余

既往史：

2007年肾占位行**右肾切除术**，术后病理为良性病灶。

2012年**直肠恶性肿瘤**，行手术治疗，术后行化疗治疗6周期。

2017-11-21在北京武警总医院行眼眶肿物活检，病理：**左眶淋巴组织不典型增生**，并于2017-11-30行左眼眶局部放疗。

2026-5-21腮腺超声：**右侧腮腺实质性占位(36.9×14.4mm)**，右侧腮腺周围可见**淋巴结(其中一个约5.4×3.0mm)**。右侧面颊皮下超声：**右侧面颊皮下软组织层实质性病灶(27.5×10.4mm)**。

2026-6-10颅底腮腺MRI平扫+增强：**右侧腮腺占位**，考虑肿瘤性病变可能，颌下小淋巴结。

临床病史

2026-6-10上下腹部+盆腔增强CT：肝左叶多发小血管瘤可能（较大者8mm），肝脏多发小囊肿可能；肝脏钙化或肝内胆管结石。胆总管稍扩张；左侧肾上腺略增粗，右肾未见显示；左肾囊肿可能；**胃幽门-十二指肠壁增厚，不均匀强化；膀胱壁、盆腔、腹壁及脐周结节，直肠及乙状结肠壁增厚，可见强化；子宫附件区域占位。考虑肿瘤性病变，转移性病变不排除。**

肺部CT平扫：**双肺多发结节及肿块影**（右肺中叶外侧段、右肺下叶后基底段、左肺下叶前内基底段，最大为左肺下叶前内基底段约67*52mm），考虑转移性肿瘤可能；**两上叶小叶间隔增厚，不排除淋巴管受累可能；前纵膈结节**（16*10mm），淋巴结肿大可能。

2026-6-12：支气管镜：左固有上叶、右上叶开口可见**脓性分泌物**，各支气管开口未见明显肿物。脱落细胞学：**镜下见部分黏膜上皮细胞及少量炎性细胞**，未见肿瘤细胞。

临床病史

重要体征:

生命体征: 体温: 36.2°C, 脉搏: 79次/分, 规则, 呼吸: 20次/分, 规则

血压: 132/73mmHg

专科情况: 神志清楚, 正力体型, 表情自如。全身皮肤黏膜无出血点及瘀斑, 浅表淋巴结未触及肿大。口唇无紫绀, 颈静脉无充盈, 甲状腺无肿大。双肺呼吸音清晰、未闻及干湿性啰音。

临床病史

外院实验室检查：

甲胎蛋白、癌胚抗原、CA153、CA125、CA199正常。

本院实验室检查：

(2026-06-24) 淋巴细胞百分数：**15.2%↓** (20-50%)；单核细胞百分数：**10.2%↑** (3-10%)；淋巴细胞总数： $0.6 \times 10^9/L \downarrow$ ($1.1-3.2 \times 10^9/L$)，3天后复查基本恢复政策。

总蛋白：**58.5 ↓ g/L**；白蛋白：**36.6 ↓ g/L**；碱性磷酸酶：**45 ↓ U/L**；总胆红素：**33.5 ↑ umol/L**；直接胆红素：**9.8 ↑ umol/L**；间接胆红素：**23.7 ↑ umol/L**；eGFR(CKD-EPI肌酐方程)：**85.04 ↓ ml/min/1.73m²**。

临床病史

肿瘤标记物：鳞状上皮细胞癌抗原：0.81ng/ml；神经元特异烯醇化酶：**23.76ng/ml↑**；细胞角蛋白19片段：3.05ng/ml。


260624974772

 洪湖市人民医院 检验报告单

常规
任院

号R

姓名： 性别：女 年龄：73岁 样本编号：-66
住院号：0002002381 科室：肿瘤内科(一) 床号：75 标本类型：血清
申请医师： 项目组合：鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法)，细 临床诊断：肺占位性病变

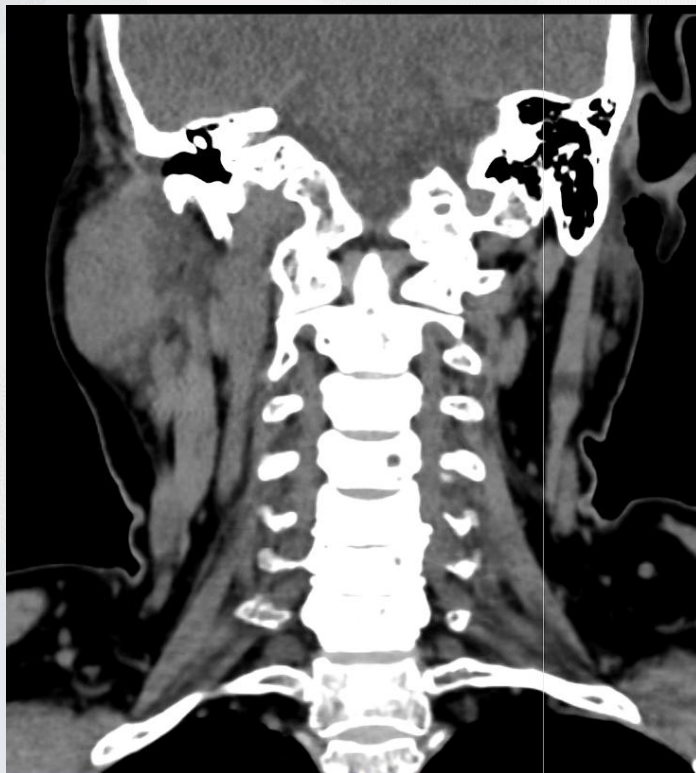
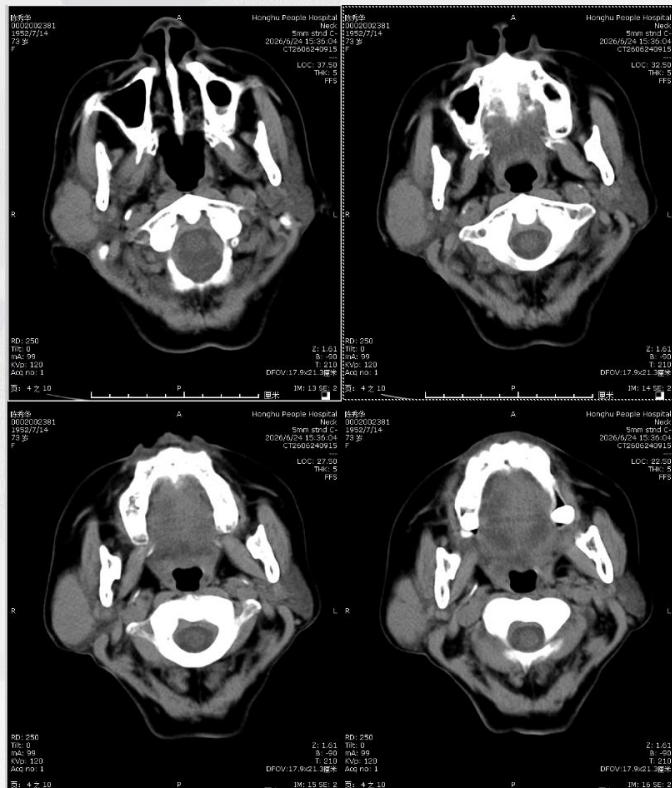
项目名称	代号	结果	单位	参考区间
鳞状上皮细胞癌抗原	SCC	0.81	ng/ml	0.0~1.65
神经元特异烯醇化酶	NSE	23.76	↑ ng/ml	0.0~14.38
细胞角蛋白19片段	CYFRA21-1	3.05	ng/ml	0.0~3.3

申请时间：2026/6/24 9:34:43 采集时间：2026/6/24 10:10:07 检验者： 审核者：
接收时间：2026-06-24 11:26:17 报告时间：2026-06-24 12:31:57
注：本报告仅对此标本负责，如有疑问请联系检验科。项目前标注★为湖北互认项目，标注▲为荆州互认检验项目！

第1页，共1页

影像学检查

2026-06-29本院行颈部CT平扫+肺部及纵隔平扫及增强



影像学检查

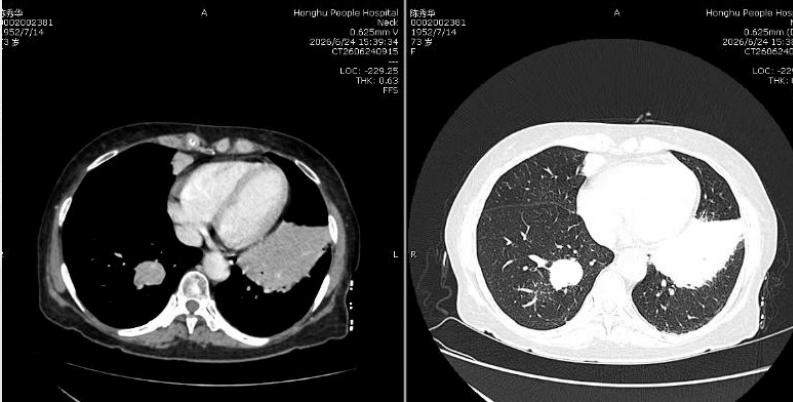
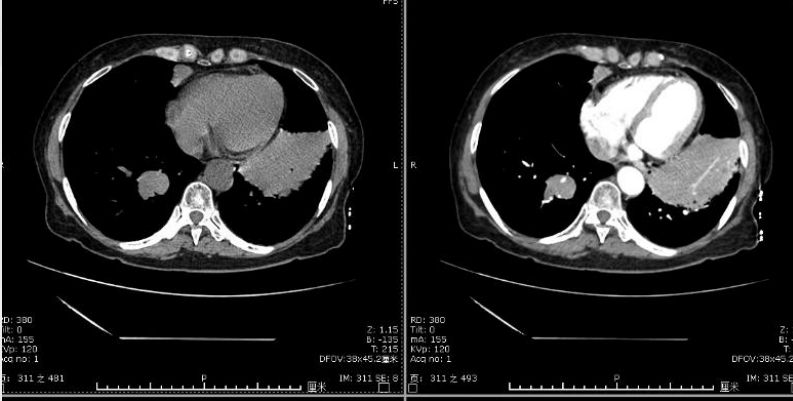
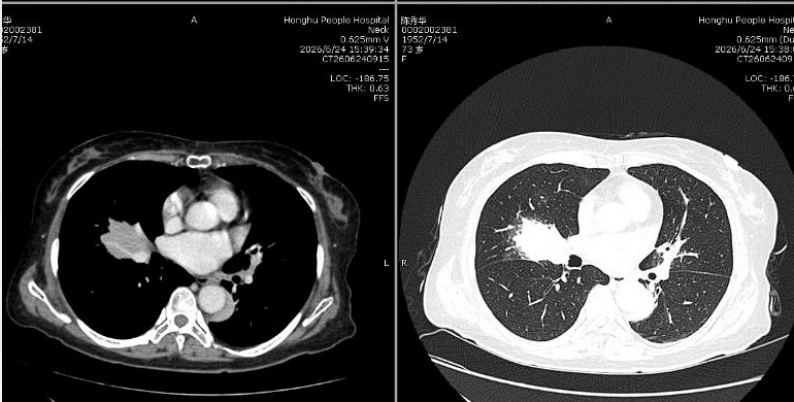
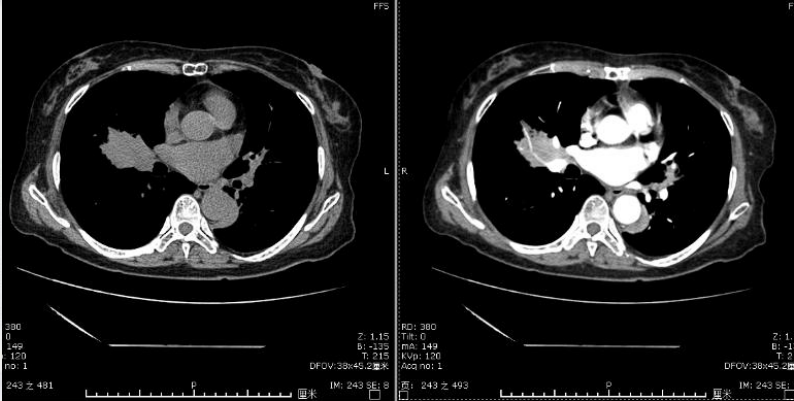
2026-06-29本院行颈部CT平扫+肺部及纵隔平扫及增强



影像学检查



影像学检查



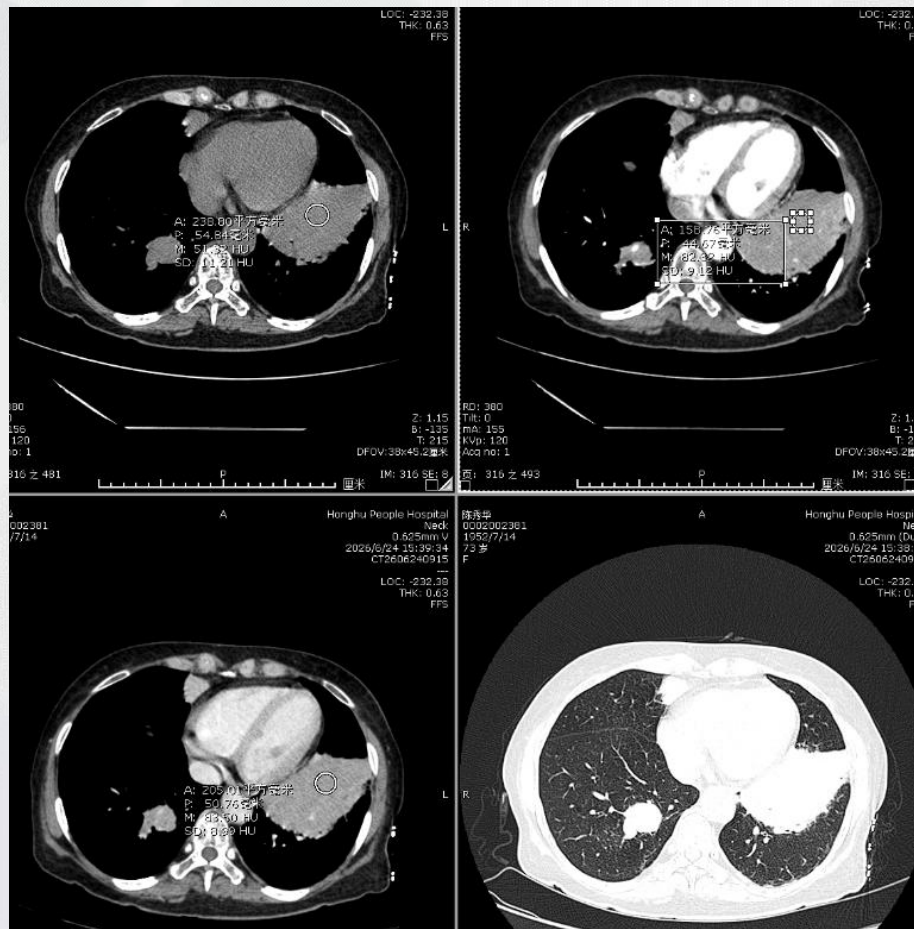
影像学特征

右侧腮腺、面颊、肺部及纵隔多发结节、肿块，密度均匀。

肺内（上叶）可见斑片状、点絮状病灶，小叶间隔增厚；

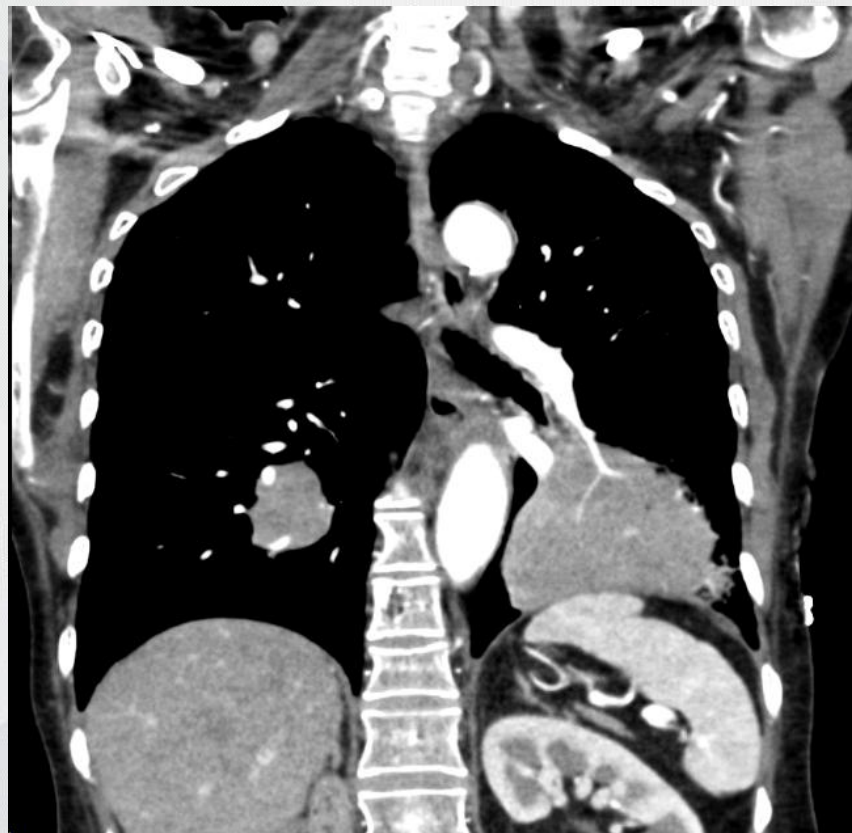
肺内结节/肿块边缘模糊，部分呈实变影，不跨叶间裂。

肺部病灶及纵隔病灶增强呈中度均匀强化，平扫CT值51HU，动脉期82HU，静脉期88HU。



影像学特征

肺部病灶可见充气支气管征及血管漂浮征。



影像诊断

结合患者既往病史，患者腮腺、面颊、肺部、纵隔、膀胱壁、盆腔、腹壁及脐周多发病灶，初步诊断**淋巴瘤**。



湖北省人民医院



扫一扫查看报告详情

影像中心检查报告单

鄂 HR

住院号: 0002002381

检查号: CT2606240915

姓名: [REDACTED]

性别: 女

年龄: 73岁

申请科室: 肿瘤内科(一)

病床: 75

检查设备: GE-64排CT

检查日期: 2026-06-24 15:35:17

检查部位: 颈部软组织CT平扫, 肺部CT平扫, 纵隔心脏大血管CT平扫, 纵隔心脏大血管CT增强(加收), 肺部CT增强(加收)

检查所见:

右侧腮腺区见团块状软组织密度影, 边缘欠清, 大小约 $37\text{mm} \times 22\text{mm} \times 45\text{mm}$ 。右侧面颊软组织增厚, 呈条片状致密影; 右侧颈部见多个增大淋巴结, 大者短径约 12mm 。双侧咽隐窝清晰, 咽后壁光滑, 轮廓清晰, 密度未见异常。会厌、双侧杓会厌皱襞、声襞走行自然, 移行区未见异常密度。双侧梨状隐窝、声门腔轮廓清楚。下颌下腺及甲状腺大小、形态及密度未见异常。

双肺纹理增多, 右肺中叶外侧段、右肺下叶后基底段、左肺下叶见多发团块状软组织密度影, 大者位于左肺下叶, 大小约 $102\text{mm} \times 61\text{mm} \times 62\text{mm}$, 表面欠光整, 边缘见晕征, 支气管受窄, 呈明显均匀强化, 见血管漂浮征; 双肺见斑片状、点絮状高密度影, 边缘模糊。心膈角旁、前纵隔胸腺区及后纵隔降主动脉旁见结节样、条片状软组织密度影, 大小分别约 $25\text{mm} \times 19\text{mm}$ 、 $13\text{mm} \times 12\text{mm}$ 、 $13\text{mm} \times 35\text{mm}$, 呈均匀轻度强化。心脏各房室大小形态正常; 主动脉及冠脉见多发钙化影。双侧胸膜未见增厚。胸腔内未见积液。

检查意见:

- 1、右侧腮腺区软组织肿块, 右侧面颊软组织增厚, 考虑肿瘤性病变, 淋巴瘤可能;
- 2、双肺、纵隔多发团块状病灶, 考虑肿瘤性病变, 多考虑淋巴瘤, 建议进一步相关检查;
- 3、双肺多发斑片状、点絮状病灶, 考虑淋巴瘤肺内浸润性病变可能, 建议复查;
- 4、主动脉及冠脉硬化。

穿刺活检及病理

原单位主要病理诊断:

(肺脏-穿刺活检): 结合免疫组化倾向
恶性淋巴瘤, 建议送省平台会诊。

X202601040-4: 免疫组化:

LCA(+), TTF-1(-), Napsin A(-),
CD56(-), Ki67(-), CK(-), Syn(-),
CgA(-);



穿刺活检及病理

病理会诊意见:

**(穿刺组织) 肺黏膜相关淋巴组织结
外边缘区淋巴瘤 (MALT淋巴瘤)。**

**免疫组化: 肿瘤细胞CD20和LCA
(+), CD21和CD23 (FDC网+),
IgD (散在弱+), CD10、BCL6
、cyclinD1、CD5、CD3和CD43
(均-), Ki67LI: 热点区约10%;
其余参见原单位病理报告。**

湖北省数智病理远程会诊中心

专家会诊报告

患者联系电话: 135-1111-1111

会诊编号: HBT202603630099

姓 名: 王某某

性 别: 女

年 龄: 73岁

申请时间: 2026-06-29 17:27:00

会诊平台: 湖北省远程病理会诊平台

原单位: 洪湖市人民医院

原病理号: X202601040

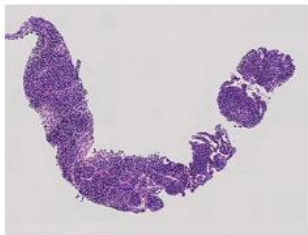
送检扫描片信息: HE×5张, 免疫×18张

原单位主要病理诊断:

(肺脏-穿刺活检): 结合免疫组化倾向恶性淋巴瘤, 建议送省平台会诊。X202601040-4: 免疫组化: LC

A(+), TTF-1(-), Napsin A(-), CD56(-), Ki67(-), CK(-), Syn(-), CgA(-);

数字切片所见:



会诊咨询意见:

(穿刺组织) 肺黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤 (MALT淋巴瘤)。

免疫组化: 肿瘤细胞CD20和LCA (+), CD21和CD23 (FDC网+), IgD (散在弱+), CD10、BCL6、cyclinD1、CD5、CD3和CD43 (均-), Ki67LI: 热点区约10%; 其余参见原单位病理报告。

MALT淋巴瘤

黏膜相关淋巴组织（MALT）淋巴瘤（MALToma），正式名称为**黏膜相关淋巴组织结外边缘区淋巴瘤（ENMZL）**，是一种低级别结外**非霍奇金淋巴瘤**，为一种成熟B细胞肿瘤。

占非霍奇金淋巴瘤的7.5%。平均发病年龄为60岁，女性略多于男性，发病率约10万/2。

MALT淋巴瘤通常发生于不含淋巴细胞的上皮组织。与慢性感染/炎症有关，例如幽门螺杆菌感染可导致胃MALT淋巴瘤，干燥综合征可导致唾液腺MALT淋巴。低级别MALT淋巴瘤转化为高级别MALT淋巴瘤的比例不足10%。

可发生于全身各处，胃：最常见；33-50%，肠道：约5%。

MALT淋巴瘤的影像学特征取决于受累器官。

肺MALT淋巴瘤

支气管相关淋巴组织淋巴瘤（BALT淋巴瘤），为原发性肺淋巴瘤最常见类型。

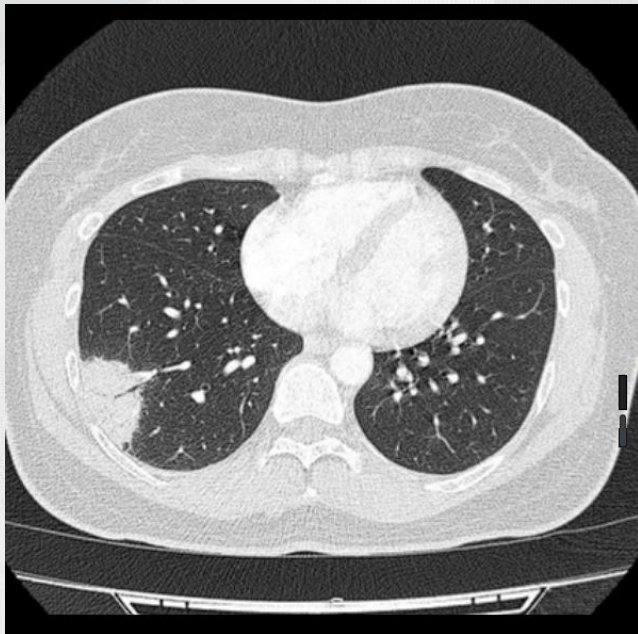
由形态单一的小淋巴细胞组成，具有局灶性浆细胞样特征。它们由分布于远端支气管和细支气管的上皮下淋巴滤泡构成。

影像学特征：

CT上常见的特征：**孤立性、边界清晰的软组织肿块，占大多数；**

不太常见特征：**多发性单侧或双侧结节；沿支气管血管束和小叶间隔的弥漫性浸润；广泛的肺叶浸润，类似实变（肺炎），伴有支气管充气征或磨玻璃样密度影；气泡状透射区。**

肺MALT淋巴瘤



右肺下叶胸膜下肿块样实变影，与胸膜广泛相邻。支气管充气征延伸至肿块深处，未见变形

小结

综合来说，当遇到肺内不明性质的结节、实变影像时，应当考虑肺MALT淋巴瘤这一可能，并与上述肺癌、感染及其他淋巴瘤等鉴别。

影像上，一些征象如肺炎样实变伴支气管充气征、实变内见血管征、多发且稳定的肺内结节等，支持MALT淋巴瘤的可能。但影像学并不能确诊，需要靠组织活检证实单克隆B细胞淋巴增殖及其免疫表型特征来确诊。如果肺内病灶位置较周边，可考虑CT引导下经皮穿刺活检；中央型病变则可通过支气管镜下活检获取组织。一旦确诊为肺MALT淋巴瘤，还需行全身评估如PET-CT，以排除疾病的肺外播散，从而确定是真正的原发性肺淋巴瘤。对于早期局限病变可手术切除并长期随访；多发病变则可考虑免疫治疗联合低强度化疗等个体化方案。总体而言，肺MALT淋巴瘤预后较好，5年生存率有报道可达约90%。关键在于早期识别和正确诊断，避免误诊误治。

小结---肺MALT淋巴瘤影像诊断与诊疗要点

1. 鉴别：肺部不明结节、实变，需排除肺癌、感染、其他淋巴瘤，警惕肺MALT淋巴瘤。
2. 影像：**肺炎样实变伴支气管充气征、实变内见血管征、多发且稳定的肺内结节**，支持MALT淋巴瘤的可能，无法确诊。
3. 确诊：外周病灶CT引导穿刺、中央病灶气管镜活检，病理见单克隆B细胞淋巴增殖及其免疫表型特征可确诊。
4. 分期：完善PET-CT排查肺外播散。
5. 治疗预后：单发病灶-手术随访，多发病灶-免疫+低剂量化疗；5年生存率约90%，早期识别和正确诊断，避免误诊误治。

- 参考文献
- 中国淋巴瘤治疗指南(2023年版)DOI:10.13455/j.cnki.cjcor.113494-20230118-0032
- 原发性肺淋巴瘤63例临床特征分析.临床肺科杂志2025,30(4)492-497
- Primary Lymphoproliferative Lung Diseases: Imaging and Multidisciplinary Approach. Diagnostics 2023, 13, 1360.
doi.org/10.3390/diagnostics1307136
- Clinical Analysis of 50 Cases of Primary Pulmonary Lymphoma: A Retrospective Study and Literature Review. Technology in Cancer Research & Treatment 2022, 21:1-10
- A case of pulmonary mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma in a patient with a history of idiopathic lymphocytic interstitial pneumonia (iLIP). General Thoracic and Cardiovascular Surgery Cases (2025) 4:24
- Differential clinical and CT imaging features of pneumonic-type primary pulmonary lymphoma and pneumonia: a retrospective multicentre observational study. BMJ Open 2023;13:e077198. doi:10.1136/bmjopen-2023-077198